

2023 국민건강영양조사 통계집

오렌지국 보건통계청 · 국민건강영양조사 제9기 2차년도 · 2024 - 12

조사 개요 및 분석 방법

국민건강영양조사는 오렌지국 보건통계청이 국민의 건강수준, 건강행태 및 영양섭취 실태를 파악하기 위해 매년 실시하는 국가승인통계이다. 제9기 2차년도에 해당하는 2023년 조사는 2023년 1월부터 12월까지 전국 192개 표본조사구에서 연중 순환 방식으로 진행되었다. 목표 표본은 조사구당 25개 가구씩 총 4,800가구이며, 만 1세 이상 가구원 전체를 조사 대상으로 하였다. 최종적으로 7,412명이 조사에 참여하여 참여율은 72.9%로 집계되었으며, 이는 제9기 1차년도의 74.1%보다 1.2%p 낮은 수준이다.

표본설계는 시도, 동·읍면, 주택유형을 층화변수로 하는 2단계 층화집락표본추출 방식을 적용하였다. 조사는 건강설문조사, 검진조사, 영양조사의 세 부문으로 구성되며, 영양조사는 검진일로부터 7일 이내에 조사원이 가구를 방문하여 24시간 회상법으로 수행하였다. 모든 지표는 표본가중치를 적용한 복합표본 분석으로 산출하였고, 연령표준화가 필요한 지표는 2020년 오렌지국 추계인구를 기준인구로 사용하였다. 분산 추정에는 층화 및 집락 정보를 반영한 테일러 선형화 방법을 적용하였다.

사회경제적 격차 분석에 사용된 분류 기준은 다음과 같다. 본 조사에서 소득수준은 가구 균등화 소득을 성·연령별로 사분위(1~4분위)로 구분하여 산출하였다.

교육수준은 초졸 이하, 중졸, 고졸, 대졸 이상의 네 범주로 구분하였으며, 거주지역은 동부와 읍면부로 나누어 제시하였다. 다만 표준오차가 큰 일부 소집단 추정치는 해석에 주의가 필요하며, 표본수가 30명 미만인 셀의 수치는 공표하지 않았다.

성인 만성질환 유병 현황

성인 만성질환 유병 현황은 검진조사 결과와 자가보고 문항을 결합하여 산출하였다. 2023년 19세 이상 성인의 비만 유병률은 남자 45.6%, 여자 27.8%였다. 비만은 체질량지수 25 kg/m^2 이상을 기준으로 정의하였으며, 남자는 30대에서 52.1%로 가장 높았고 여자는 70세 이상에서 39.7%로 가장 높은 수준을 보였다. 제9기 1차년도와 비교하면 남자는 1.2%p 상승하고 여자는 0.5%p 하락하여 성별 격차가 다소 확대되었다.

순환기 및 대사질환 지표에서는 고혈압 유병률이 남자 26.9%, 여자 19.2%로 나타났고, 당뇨병 유병률은 남자 14.1%, 여자 9.7%로 조사되었다. 고콜레스테롤혈증 유병률은 남자 20.3%, 여자 22.6%로 여자가 다소 높았다. 고혈압 유병자 중 약물 치료를 받고 있다고 응답한 비율은 71.5%였으며, 당뇨병 유병자의 혈당 조절률은 27.9%에 머물렀다. 만성질환의 인지율과 치료율은 지난 5년간 완만하게 개선되었으나 조절률의 개선 폭은 제한적이었다.

건강행태 지표를 함께 살펴보면 현재흡연율은 남자 31.8%, 여자 6.3%였고, 고위험 음주율은 남자 21.7%, 여자 7.2%로 조사되었다. 유산소 신체활동 실천율은 47.3%로 전년 대비 1.6%p 상승하였다. 이러한 결과는 체중 관리와 대사질환 예방을 위한 중재가 특정 연령·성별 집단에 집중될 필요가 있음을 시사한다. 다만 유병률 지표 중 일부는 자가보고에 의존하므로 과소 보고 가능

성을 배제할 수 없다.

소득수준별 의료이용

의료이용 지표는 최근 1년간 병원 방문 경험, 미충족 의료 경험, 연간 입원율을 중심으로 분석하였다. 소득수준 하위 25% (소득 1분위) 성인의 미충족 의료율은 8.4%로, 상위 25% (소득 4분위)의 3.1%보다 높았다. 미충족 의료의 주된 사유로는 '시간이 없어서'가 38.2%로 가장 많았고, '경제적 이유'가 22.5%, '증상이 경미하다고 생각해서'가 17.9%로 뒤를 이었다. 특히 1분위에서는 경제적 이유의 비중이 41.6%로 크게 높아, 사유 구성이 분위별로 상이한 양상을 보였다.

연간 입원율은 1분위 12.8%, 2분위 9.4%, 3분위 8.1%, 4분위 7.6%로 소득이 낮을수록 높게 나타났다. 반면 최근 2년간 건강검진 수진율은 1분위 58.4%, 4분위 76.2%로 역전된 분포를 보였다. 필요한 치과 진료를 받지 못한 비율은 전체 성인 기준 11.3%로 일반 의료에 비해 높은 수준이 유지되었다. 제9기 1차년도와 비교할 때 전체 미충족 의료율은 0.4%p 감소하였으나 분위 간 격차는 통계적으로 유의하게 축소되지 않았다.

본 결과는 응답자의 자가보고에 기초하므로 실제 의료 필요를 과소 또는 과대 추정할 가능성이 있다. 또한 소득 분위는 조사 시점의 가구 소득 신고에 근거하므로 자산 보유 수준이나 부채 부담은 반영되지 않는다. 그럼에도 소득 하위 집단에서 예방적 의료이용은 낮고 입원 이용은 높은 구조가 반복적으로 관찰된다는 점은 정책적 함의가 크다. 향후 지역 단위 의료자원 분포 자료와의 연계 분석이 필요하다.

아동·청소년 식생활

아동·청소년 식생활 지표는 6~18세 응답자 1,284명을 대상으로 산출하였다. 2023년 6~18세 아동·청소년의 아침식사 결식률은 34.6%였다. 결식률은 12~18세에서 41.2%로 6~11세의 24.9%보다 크게 높았으며, 남녀 간 차이는 2.3%p로 크지 않았다. 제9기 1차년도와 비교하면 전체 결식률은 2.8%p 상승하여 최근 3개 조사년도 중 가장 높은 수준을 기록하였다.

외식 및 가공식품 섭취와 관련한 지표도 함께 조사하였다. 6~18세 아동·청소년의 주 1회 이상 패스트푸드 섭취율은 27.4%였다. 주 3회 이상 탄산음료 섭취율은 18.6%였고, 하루 1회 이상 과일·채소를 섭취한 비율은 42.7%에 그쳤다. 1일 평균 나트륨 섭취량은 3,120mg으로 권고 수준을 상회하였으며, 당류 섭취량은 총 에너지 섭취량의 11.9%를 차지하였다.

식생활 지표는 가구의 사회경제적 특성에 따라 차이를 보였다. 아침식사 결식률은 소득 1분위에서 39.8%, 4분위에서 30.5%로 나타났고, 읍면부가 동부보다 1.9%p 높았다. 다만 영양조사는 단일 회차의 24시간 회상법에 기초하므로 개인의 일상적 섭취 수준을 대표하는 데 한계가 있다. 학교 급식 및 가정 내 식생활 환경을 함께 고려한 중재 설계와, 연속 조사년도 자료를 결합한 추세 분석이 요구된다.